

RZV 1

Herpes zoster vaccine

תרכיב נגד שלבכת חוגרת

התרכיב נגד שלבכת חוגרת מיועד למניעת שלבכת חוגרת (herpes zoster) ונוירלגיה פוסט-הרפטית (post-herpetic neuralgia).

הערה: זוסטבאקס (ZOSTAVAX), חיסון חי-מוחלש שהיה בשימוש בישראל עד 2023, אינו בשימוש ואינו מומלץ עוד.

1. שם התרכיב והרכבו

1.1. שם התרכיב: Shingrix, תוצרת (GSK) GlaxoSmithKline.

1.2. אחרי הכנת התרכיב, מנה אחת (0.5 מ"ל) מכילה 50 mcg של Varicella zoster virus glycoprotein E antigen.

1.3. רכיבים נוספים:

Adjuvanted with AS01_B containing:

Plant extract Quillaja saponaria Molina, fraction 21 (QS-21) [50 mcg]

3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) from Salmonella minnesota [50 mcg]

3 glycoprotein E (gE) produced in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells by recombinant DNA technology

Powder (gE antigen): Sucrose, Polysorbate 80, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Dipotassium phosphate.

Suspension (AS01_B Adjuvant System): Dioleoyl phosphatidylcholine, Cholesterol, Sodium chloride, Disodium phosphate anhydrous, Potassium dihydrogen phosphate, Water for injection

2. אחסון התרכיב

2.1. יש לאחסן את התרכיב במקרר בטמפרטורה של בין 2°C ל-8°C, ובאריזה המקורית, על מנת למנוע את חשיפת התרכיב לאור.

2.2. העברת התרכיב תיעשה בצידניות עם קרחומים. אין להקפיא את התרכיב.

3. פרזנטציה והכנת התרכיב

3.1. התרכיב מגיע בשני בקבוקונים נפרדים: בקבוקון המכיל תרחיף חלבי, חסר צבע עד חום בהיר, ובקבוקון המכיל אבקה לבנה.

3.2. התרכיב מגיע באריזה של מנה בודדת (בבקבוקון אחד של אבקה ובקבוקון אחד של תרחיף) או באריזה של 10 מנות (10 בקבוקוני אבקה ו-10 בקבוקוני תרחיף).

RZV 2

- 3.3. לשחזור התרכיב יש לשאוב את כל תכולת בקבוקון התרחיף לתוך מזרק, ולרוקן את תכולת המזרק לתוך הבקבוקון עם האבקה. יש לנער בעדינות עד שהאבקה מתמוססת לחלוטין.
- 3.4. לאחר השחזור יתקבלו 0.5 מ"ל של נוזל צלול, בצבע שקוף עד חום בהיר מאד.
- 3.5. לפני ההזרקה יש לוודא שאין חלקיקים או שינוי בצבע התרכיב.
- 3.6. יש להשתמש בתרכיב מיד לאחר ההכנה. ניתן לשמור במקרר את התרכיב המוכן בטמפרטורה של בין 2°C ל- 8°C , עד 6 שעות מההכנה.

4. אופן ההזרקה

- 4.1. התרכיב מיועד להזרקה לתוך השריר בלבד (IM), בעדיפות לשריר הדלטואיד.
- 4.2. הנחיות נוספות להזרקה ניתן למצוא ב**תדריך החיסונים – פרק הוראות כלליות**.

5. מינון

- 5.1. החיסון ניתן בשתי מנות, בהפרש של 2-6 חודשים ביניהן.
- 5.2. אם עברו יותר מ-6 חודשים ממתן המנה הראשונה, יש לתת את המנה השנייה בהקדם האפשרי. בכל מקרה אין צורך להתחיל את הסדרה מחדש.
- 5.3. עבור מטופלים הצפויים לפתח דיכוי חיסוני, ועבורם יש צורך בלוח זמנים קצר יותר, ניתן לתת את המנה השנייה החל מ-4 שבועות לאחר המנה הראשונה.
- 5.4. אם המנה השנייה ניתנה תוך פחות מ-4 שבועות מהמנה הראשונה, המנה השנייה אינה נספרת, ויש לתת מנה נוספת לפחות 4 שבועות לאחר שניתנה.

6. מתן התרכיב עם תכשירים אחרים

- 6.1. ניתן לתת את התרכיב בו-זמנית עם כל תרכיב אחר, ובכל פרק זמן לפני תרכיבים אחרים או אחריהם.
- 6.2. כאשר תרכיבים ניתנים בו-זמנית, יש להזריקם בגפיים שונות. אם לא ניתן, יש להפריד בין שני איזורי ההזרקה לפחות 2.5 ס"מ זה מזה.
- 6.3. ניתן לחסן בשינגריקס מטופלים הנוטלים טיפול אנטי-ויראלי (כגון אציקלוביר, פאמציקלוביר, ואלציקלוביר ודומיהם). במטופלים הנוטלים טיפול אנטי-ויראלי פרופילקטי, כגון מושתלי מח עצם, מומלץ לתת את החיסון חודשיים לפני הפסקת הטיפול האנטי-ויראלי.

***הערה: חיסון Shingrix יכול לגרום ל-seroconversion לאבעבועות רוח. אבל - הוא אינו מגן מפני אבעבועות רוח ראשוניות, אלא רק מפני התפרצות שלבוקת אצל מי שכבר חלה. עקב כך, סרולוגיה חיובית לאבעבועות רוח לאחר החיסון בשינגריקס (אצל מושתלי מח עצם, או מי שאין לו תיעוד על מחלת אבעבועות רוח בעברו) אינה קבילה כעדות להגנה מפני מחלה ראשונית של אבעבועות רוח.**

RZV 3

7. התוויות

החיסון מומלץ לקבוצות הבאות:

7.1. בני 50 שנים ומעלה.

הערה: התרכיב מומלץ לשימוש בבני 50 שנה ומעלה, אך הורית הגיל הנכללת בסל הבריאות לאנשים ללא מחלת רקע היא לבני 65 ומעלה.

7.2. בני 18 ומעלה הנמצאים בסיכון לשלבקת חוגרת:

7.2.1 סובלים מדיכוי חיסוני ראשוני

7.2.2 מושגלי מח עצם

7.2.2.1 השתלה אוטולוגית – מומלץ לחסן לפחות 3-12 חודשים לאחר ההשתלה, בהתאם

להפסקת נטילת הטיפול האנטי-ויראלי.

7.2.2.2 השתלה אלוגנאית – מומלץ לחסן לפחות 6-12 חודשים לאחר ההשתלה, בהתאם

להפסקת נטילת הטיפול האנטי-ויראלי.

7.2.3 מושגלי איברים סולידיים – מומלץ לחסן לפני ההשתלה. במידה ולא ניתן, מומלץ לחסן 6-12 חודשים לאחר ההשתלה, כאשר ישנה יציבות מבחינת הדיכוי החיסוני ומבחינת תפקוד השתל (לא בסמוך לדחיה של השתל).

7.2.4 מטופלים בתרופות המדכאות את מערכת החיסון – מומלץ לחסן לפחות חודש לפני התחלת הטיפול. אם לא חוסנו לפני הטיפול אפשר לחסן, בהתאם להמלצת הרופא המטפל, גם בזמן נטילת הטיפול ועד חצי שנה לאחר סיום הטיפול:

7.2.4.1 סטרואידים – טיפול קבוע במינון יומי ≤ 20 מ"ג ליום

7.2.4.2 Disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) – כגון מתוטרקסט, פלקווניל, הידרוקסיכלורקווין, סולפהסלזין, אזאתיופרין ודומיהם.

7.2.4.3 מעכבי TNF-alpha

7.2.4.4 תרופות ביולוגיות

7.2.4.5 כימותרפיה

7.2.4.6 תרופות כנגד תאי B, כולל לדוגמא anti CD20 כגון ריתוקסימאב ודומיהם.

7.2.4.7 טיפול CAR-T (chimeric antigen receptor T cell)

7.2.5 נשאי HIV

7.2.6 כל מצב חסר חיסוני אחר, על פי ייעוץ רופא מומחה במחלות זיהומיות או רופא מטפל אחר המומחה בתחום.

8. הוריות נגד ואזהרות

8.1. הוריות נגד: רגישות יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרכיב.

8.2. אזהרות:

8.2.1 מחלת חום חדה – 38 מעלות צלזיוס ומעלה, יש לדחות את מתן החיסון עד להחלמה. מחלה

קלה ללא חום, או מחלה המלווה בחום לא גבוה (מתחת ל-38 מעלות צלזיוס), אינה סיבה לדחיית החיסון.

RZV 4

- 8.2.2 **הריון**: אין סיכון ידוע הקשור למתן חיסונים או טוקסואידים נגיפיים או חיידקיים מומתים, רקומביננטיים, במהלך ההריון. אם יש צורך בכך, ניתן לשקול מתן שינגריקס במהלך ההריון.
- 8.2.3 **הנקה**: חיסונים רקומביננטיים כמו RZV אינם מהווים סיכון ידוע לאמהות מניקות או לתינוקות שלהן. אם החיסון נדרש, על הרופא המטפל לשקול מתן התרכיב ללא קשר למצב ההנקה.
- 8.3 יש לתת את החיסון גם למי שלקו בעבר בשלבקת חוגרת, המשתייכים לאחת הקבוצות המומלצות, מכיוון שמחלה זו עלולה לחזור. מומלץ לדחות את מתן התרכיב עד לאחר ההחלמה מהשלב האקוטי של שלבקת חוגרת, כלומר עד להגלדת כל הפצעים. יש לחסן במינון מלא של 2 מנות חיסון, כמפורט בסעיף 6 בפרק זה.
- 8.4 מומלץ לתת את החיסון גם למי שחוסנו בעבר בחיסון חי-מוחלש נגד שלבקת חוגרת (Zostavax), המשתייכים לאחת הקבוצות המומלצות.

9. תופעות בסמיכות לקבלת התרכיב

- 9.1 בבני 50 שנים ומעלה התופעות המדווחות בשכיחות גבוהה הן: כאב באזור ההזרקה (68.1% בסה"כ, 3.8% במידה חזקה), כאבי שרירים (32.9% בסה"כ, 2.9% במידה חזקה), עייפות (32.2% בסה"כ, 3.0% במידה חזקה), כאב ראש (26.3% בסה"כ, 1.9% במידה חזקה). רוב התגובות הללו היו קצרות-טווח. התגובות שדווחו כחזקות נמשכו כ-1-2 ימים.
- 9.2 הודגם קשר סטטיסטי בין החיסון לתסמונת גיליאן-ברה, בשיעור של כ-6 מקרים חדשים על כל מיליון מנות חיסון. טרם הוכח קשר סיבתי.
- 9.3 שכיחות הדיווחים על כאבי שרירים, עייפות, כאב ראש, צמרמורת, חום ותסמינים במערכת העיכול (כולל בחילה, הקאה, שלשול, וכאב בטן) היתה גבוהה יותר בבני 50-69 שנים בהשוואה לבני 70 שנים ומעלה.
- 9.4 פרופיל הבטיחות במדוכאי חיסון בני 18 שנים ומעלה היה דומה לזה שבבני 50 שנים ומעלה. בקבוצה זו, כאבים באזור ההזרקה, עייפות, כאב ראש, כאבי שרירים, צמרמורת וחום היו שכיחים יותר בבני 18-49 שנים בהשוואה לבני 50 שנים ומעלה.
- 9.5 לפרטים נוספים על תופעות בסמיכות לקבלת התרכיב יש לעיין בעלון היצרן.

10. רישום, מעקב ודיווח

- 10.1 רישום החיסון יתבצע כמפורט בפרק 'חיסונים – הוראות כלליות'.
- 10.2 יש להדריך את המטופל או המטפל בו לעקוב אחר תופעות בסמיכות לקבלת החיסון ולפנות לגורם מקצועי להערכה במידת הצורך.
- 10.3 על הגורם המקצועי להיות ער לאפשרות של תופעות בסמיכות לקבלת החיסון ולדווח עליהן למשרד הבריאות.

RZV 5

- 10.4. הדיווח על אירועים בסמיכות לקבלת החיסון יתבצע על ידי הצוות המחסן ו/או הצוות הרפואי המטפל, ויכלול את המידע המפורט בטופס הדיווח הייעודי של האגף לאפידמיולוגיה בשירותי בריאות הציבור, ראו [כאן](#). הדיווח הינו פרטני ללא פרטים מזהים, אך על המדווח לשמור את הפרטים המזהים ברשומות לצורך השלמת מידע רפואי במידת הצורך. את הטופס יש להעביר לאגף לאפידמיולוגיה באמצעות מייל לכתובת: AEFI.Israel@moh.gov.il
- 10.5. מוסדות רפואיים המחוברים למערכת "נחילאלי" של משרד הבריאות ידווחו ישירות במערכת.
- 10.6. על אירועים חמורים אשר גרמו למתן טיפול דחוף במסגרת הקהילה, לפינוי למחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד), לאשפוז או לפטירה יש לדווח מידית בכתובים וגם טלפונית לאחראי מערך אירועים מיוחדים - עו"ד פיראס חאיק, מס' נייד 050-6242380, בדוא"ל: firas.hayek@moh.gov.il וכן למייל: AEFI.Israel@moh.gov.il.